MODUL 1

ENTERPRISE ARSITEKTUR

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 1
TUJUAN PRAKTIKUM

a) Menjelaskan definisi, tujuan, dan komponen utama Enterprise Architecture (EA).

b) Mengidentifikasi visi, misi, tujuan strategis, serta memetakan pemangku kepentingan (stakeholder) organisasi.

c) Menganalisis kondisi eksisting organisasi dan mengelompokkan permasalahan TI ke dalam empat domain utama EA (BDAT: Bisnis, Data, Aplikasi, Teknologi

Visi dan Misi

Visi

Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh dan responsif;
4. Menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan

   mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Tujuan Strategis

- Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
- Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau
- Sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh dan responsive
- Tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan
- Teknologi Kesehatan yang maju
- Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien

Tabel 1.1 Peta Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan (Concern)	Pengaruh (T/S/R)	Strategi Keterlibatan
Menteri Kesehatan & Wakil Menteri	Pengambil keputusan tertinggi	Target kesehatan nasional (pilar ke-6 transformasi kesehatan) tercapainya target RPJMN, anggaran	T	Laporan singkat tentang perkembangan dan hasil program

		tepat sasaran, dan keterbukaan informasi publik kesehatan		
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pengembang dan pengelola sistem TI	Standarisasi arsitektur data (SatuSehat)ntegrasi API antar fasilitas layanan kesehatan, nasional, sistem jarang down, data aman dari peretasan	T	Rapat rutin dan penyusunan standar pertukaran data
Sekretariat Jendral (Biro Perencanaan, Keuangan, Hukum, dan Organisasi)	Penyedia anggaran, regulasi aturan, dan izin administrasi	Kepatuhan terhadap undang-undang atau hukum, pencairan dana lancar, dan keselarasan arsitektur dengan SPBE Nasional	T	Koordinasi penyusunan regulasi (Permenkes), sinkronisasi dokumen rencana kerja dan anggaranbai
Direktorat Jenderal Teknis (Kesmas, P2P, Yankes, Farmalkes)	Pemegang proses bisnis layanan kesehatan	Data pasien dan penyakit akurat, puskesmas/RS mudah mengirim laporan, dan kebutuhan obat dan alat kesehatan terpenuhi	S	Focus Group Discussion proses bisnis per direktorat, workshop alur data pasien dan fasilitas layanan kesehatan
Inspektorat Jenderal	Pengawas kepatuhan dan manajemen resiko	Pencegahan kebocoran data, efektivitas audit sistem informasi	S	Audit tata kelola berkelola, dan laporan kepatuhan secara berkala
Penyedia Layanan Kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, dan Apotek)	Pengguna sistem dan memberikan data kesehatan	Kemudahan integrasi RME (Rekam Medis Elektronik) ke platform SatuSehat, dan sistem yang stabil dan tidak sering down ataupun error	S	Pelatihan integrasi API, dan saluran bantuan (helpdesk)
Masyarakat atau Pasien	Menggunakan layanan kesehatan	Kemudahan akses Riwayat resume medis (SatuSehat), kecepatan layanan	R	Survei kepuasan public, dan

		kesehatan, dan perlindungan privasi data rekam medis.		layanan aduan masyarakat

Tabel 1.2 Identifikasi Masalah per Domain

Domain	Masalah yang Ditemukan	Dampak bagi Organisasi
Bisnis	- Pegawai harus input data pasien secara berkala ke berbagai aplikasi program Kementerian yang berbeda - Alur rujukan antar-rumah sakit masih mengandalkan berkas fisik	- Waktu nakes melayani pasien tersita pada saat administrasi - Antrean pasien makin lama karena proses manual di loket
Data	- Format data rekam medis di tiap klinik dan Rumah Sakit berbeda-beda - Data pasien tidak terintegrasi satu sama lain	- Dokter di RS rujukan tidak bisa melihat Riwayat alergi atau resep obat dari fasilitas layanan kesehatan sebelumnya - Resiko salah diagnosis dan pasien harus mengulang tes lab yang sama
Aplikasi	- Aplikasi kesehatan pusat dan daerah tidak terintegrasi - Nakes dan warga harus mengingat banyak akun untuk layanan yang berbeda-beda	- Biaya operasional dan maintenance server atau aplikasi overbudget - Tenaga medis dan Masyarakat bingung karena terlalu banyak aplikasi
Teknologi	- Server fasilitas layanan kessehatan di daerah masih mandiri, dan koneksi internet yang tidak stabil - Backup data dan keamanan siber tidak merata	- Sistem down saat jam sibuk antrean pasien - Rawan kebocoran data medis dan serangan virus

Pertanyaan Evaluasi

1. Karena banyaknya sistem informasi yang berjalan masing-masing sehingga terjadi silo yang mengakibatkan data pasien yang tidak sinkron antar layanan kesehatan, tenaga medis yang keberatan karena harus menginput data yang sama berulang kali ke sistem yang berbeda, dan biaya pengadaan dan maintenance server yang sangat boros.
2. Entreprise Arsitektur merupakan kerangka menyeluruh bagaimana organisasi dapat berjalan dan menyelaraskan domainnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi Sedangkan pada Arsitektur Sistem adalah suatu model yang mendefinisikan struktur, dan hubungan antar-komponen di dalam sebuah sistem terintegrasi
3. Menteri kesehatan merupakan stakeholder yang paling berpengaruh. Dikarenakan integrasi sistem dan data kesehatan nasional yang melibatkan puluhan ribu fasilitas kesehatan diberbagai daerah memerlukan regulasi yang hanya dapat diterbitkan oleh Menteri Kesehatan

KESIMPULAN

Kementerian Kesehatan RI memerlukan perencanaan arsitektur yang terstruktur untuk mendukung transformasi digital di bidang kesehatan. Berdasarkan pemetaan profil organisasi, stakeholder, dan permasalahan BDAT (Bisnis, Data, Aplikasi, Teknologi) integrasi data dan proses bisnis antar-fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu dikembangkan. Penerapan Enterprise Architecture dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan sistem informasi kesehatan nasional melalui platform SatuSehat.